



Jason Lin <cre062400@gmail.com>

[20250521] AI Triage 進度討論

2 messages

Johnny Fang 方偉翰, imedtac Corp. <Johnny.Fang@imedtac.com>

Thu, May 21, 2026 at 1:35 PM

To: "cre062400@gmail.com" <cre062400@gmail.com>, "max870121@gmail.com" <max870121@gmail.com>, "Jason Miao 苗中聖, imedtac Corp." <Jason.Miao@imedtac.com>, "Ben Siu 蕭銳輝, imedtac Corp." <Ben.Siu@imedtac.com>
Cc: "Ken Yu 余金樹, imedtac Corp." <Ken.Yu@imedtac.com>, "ytwu@nycu.edu.tw" <ytwu@nycu.edu.tw>

Hi all,

關於今天討論 AI Triage 系統預計於 6/10 日左右進行的美國客戶 Demo 情境規劃摘要如下：

重點摘錄

1. 系統流程與 API 架構調整

- Demo 流程為「先量測、後問答」：為了最小化雙方工程資源的投入與系統大改動，定為使用者先在設備上完成 Vital Signs 量測並上傳後，再開始進行 AI 問題的詢問
- API 調整：合併 Endpoint 1 與 3。當 imedtac 上傳完量測數據後，陽交大回傳 Session Key 與第一題問題，後續再透過 Endpoint 2 進行一問一答

2. 使用者介面 (UI/UX) 設計

- 題型限制：考量到 Kiosk 的操作便利性（避免滑動或複雜互動），AI 生成的問題將為「單選」或「複選」題
- 檢傷結果展示：為了 Demo 需求，imedtac 會在流程最後特別開啟一個預覽按鈕或頁面，用來展示 AI 整理的 SOAP 摘要與檢傷結果（實務上此結果應傳回 HIS 系統，不會直接顯示給病患看）
- 語音功能：本次 Demo 暫不納入語音互動功能，不需額外準備麥克風設備

3. Demo 劇本與情境規劃（針對美國客戶）

- 先採用「心跳過快（心律不整/胸悶）」的緊急情境來做主打 Demo，以便現場人員透過運動拉高心率來真實呈現數值異常的 AI 判斷

Action Items

imedtac

- 建立技術溝通管道：建立雙方工程團隊可以直接溝通的群組（如 Microsoft Teams 或 LINE），以加速後續開發討論
- UI 流程實作：
 - 配合「先量測、後問答」流程調整 Kiosk 介面，並在量測報告後方加上一個可觀看 AI 檢傷結果的 Demo 用按鈕/頁面

- 生成的問題將為「單選」或「複選」題

陽交大

- 調整 API 邏輯：配合決議，將 API 流程改為收到量測數據後才核發 Session Key 並開始問答的循序模式
- 提供 Demo 腳本：根據現場實測的可行性（心跳過快情境），進一步完善劇本的相關參數與 AI 預期產出

Thanks,
Johnny

Johnny Fang / 方偉翰

iMedtac Co., Ltd. www.imedtac.com

Rm. 4, 10F., No.335, Ruiguang Rd. Neihu Dist., Taipei City 11492, Taiwan (R.O.C)

本通訊及其所有附件所含之資訊均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散布本通訊。若您非指定之收件人，嚴禁使用、保存或揭露本通訊之任何部分，請通知寄件人並完全刪除本通訊。網路通訊可能含有病毒，收件人應自行確認本郵件是否安全。此外，該電子訊息內容可能被變更，且網際網路並不保證該電子訊息內容之完整性，因此，慧誠智醫股份有限公司及其關係企業對於他人變更、修改、竄改或偽造之電子訊息內容，恕不負任何責任。 The information contained in this communication and attachment is confidential and is for the use of the intended recipient only. Any disclosure, copying or distribution of this communication without the sender's consent is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this communication entirely without using, retaining, or disclosing any of its contents. Internet message cannot be guaranteed to be virus-free. The recipient is responsible for ensuring that this message is virus free. Besides, the Message is susceptible to alteration and cannot guarantee the integrity of the Message. Therefore, imedtac Co., Ltd. and its affiliates shall not be liable for the Message if altered, modified, changed or falsified by any third party.

Jason Lin <cre062400@gmail.com>

Fri, May 22, 2026 at 12:17 PM

To: "Johnny Fang 方偉翰, imedtac Corp." <Johnny.Fang@imedtac.com>

Cc: "max870121@gmail.com" <max870121@gmail.com>, "Jason Miao 苗中聖, imedtac Corp."

<Jason.Miao@imedtac.com>, "Ben Siu 蕭銳輝, imedtac Corp." <Ben.Siu@imedtac.com>, "Ken Yu 余金樹, imedtac Corp." <Ken.Yu@imedtac.com>, "ytwu@nycu.edu.tw" <ytwu@nycu.edu.tw>

Ben、Lauren、Johnny 大家好，

依照 5/21 會議後確認的方向，隨信附上 NYCU 端整理的 endpoint API 回覆文件與相關範例，供貴司工程團隊進行六月 demo 串接準備。

本版 demo contract 聚焦在最小可跑通流程：

1. iMVS 完成 vital-sign measurement 後，呼叫 NYCU start-session endpoint。
2. NYCU 回傳 `session_key` 與第一題 question object。
3. iMVS 透過 answer endpoint 回傳 `selected_option_ids`。
4. NYCU 回傳下一題，或最後回傳 `staff_review_summary` 供 staff / doctor / customer demo preview 使用。

針對使用者不確定或答不出來的情境，建議使用明確的 `not_sure` option id，而非 generic skip。這樣雙方在 API 與 summary 中都能保留可解讀的回答狀態。

為了讓雙方工程串接穩定，我們建議這份文件送出後作為六月 demo 的 API implementation baseline。若後續需要調整 endpoint、欄位名稱、required/optional、enum、answer behavior 或 UI constraints，

再由雙方明確提出並確認 change request，避免工程端依據不同版本實作。

再麻煩貴司協助確認幾項串接資訊：

1. iMVS UI 對 question template、option 數量、label 長度與 no-scroll 顯示限制。
2. Demo 環境中的 API base URL、CORS / firewall / authentication 路徑。
3. staff_review_summary 在貴司 UI 中預計顯示的位置。

謝謝，

林家聖 (Jason Lin)

國立陽明交通大學

醫工學院 生醫光電研究所 博士班

Email: cre062400@gmail.com

[Quoted text hidden]

2 attachments



2026-05-21-imedtac-two-endpoint-api-reply.md
14K



iMVS__NYCU_AI_Triage_Demo_有關_Endpoint_API_回覆文件.pdf
887K